

内镜下尿道成形术 (TUITMR)

患者须知 · 无切口修复膀胱颈瘢痕

WARWIKI

本手术通过内镜修复膀胱颈或前列腺手术后膀胱与尿道吻合处的瘢痕狭窄，全程无需体外切口。医生切开瘢痕后，将健康的膀胱黏膜缝合覆盖其上，使该区域愈合后保持通畅，而非再次瘢痕闭合。

关于这项手术

前列腺手术或放疗后，**膀胱颈**或膀胱与尿道的吻合处可形成瘢痕狭窄，阻碍尿流。单纯切开瘢痕后，常因原始瘢痕组织暴露而再次闭合。

本技术 — **TUITMR**（经尿道切开联合横向黏膜再对位）— 解决了这一问题：

- 医生通过内镜**切开瘢痕**，开放通道。
- 再用专用**缝合器械**将健康的膀胱黏膜推移覆盖切开处并缝合 — 类似皮瓣修复，但全程经尿道完成。

初步结果令人鼓舞：单次手术后约**十分之九**的患者通道保持通畅，经第二次手术后几乎全部通畅 — 且首批报道中新发尿漏风险极低。

安全吗？

手术全程经尿道进行，无需较大的机器人或开放手术。初步证据令人鼓舞，包括新发尿漏风险低 — 而尿漏正是此部位其他修复术的常见并发症。风险包括出血、尿路感染（UTI）及狭窄复发。这是一项较新的专科技术。

名词解释

膀胱颈

膀胱收窄并延续为尿道的出口处。

膀胱颈挛缩

膀胱颈处的瘢痕狭窄，阻碍尿流。

吻合口狭窄（VUAS）

前列腺手术后膀胱与尿道重新连接处形成的瘢痕狭窄。

尿道

将尿液输送至体外的管道。

黏膜（内层）

被推移覆盖瘢痕以促进其开放愈合的健康内层组织。

膀胱镜（内镜）

医生操作所用的细管状摄像设备。

尿失禁

尿液漏出 — 本技术致力于将此风险降至最低。

导尿管

愈合期间短暂留置于尿道的软管。

会疼吗？ 手术在麻醉下进行，全程无感觉。术后数日内可能有轻微烧灼感和淡红色尿液。导尿管将短暂留置。大多数患者当天出院或短暂住院后出院。

如何准备（手术前）

- 手术在**全身麻醉**下进行 — 请严格遵守术前禁食禁水及停药（包括抗凝药）的要求。
- 需进行**尿液检查**排除感染 — 如有感染须先行治疗。
- 做好**短期带管**的准备，并安排人员接送回家。

请提前告知您的医疗团队，若您：

- 正在服用**抗凝药**，或当前存在尿路感染
- 曾接受**前列腺手术、放疗**或此部位的其他治疗

手术过程

- 1 您在麻醉状态下入睡，同时给予抗生素预防感染。
- 2 内镜推进至瘢痕处，置入导丝以确保安全。
- 3 扩张并切开瘢痕，开放通道。
- 4 经尿道送入缝合器械，将健康膀胱黏膜推移并缝合覆盖切开处，随后留置导尿管。

之后

- **当天出院或短暂住院**，携带导尿管回家，留置时间较短。
- 数日内可有**轻微烧灼感和淡红色尿液**，多饮水有助于缓解。
- 数周内**避免重体力劳动和用力屏气**。
- 术后约**4个月**行内镜复查，确认通道持续通畅。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- **无法排尿**，尤其是拔除导尿管后
- **新发大量尿液漏出**
- 大量出血、血块或疼痛加剧

需要记住的三件事

1. 这是一项无切口的膀胱颈瘢痕修复手术 — 切开瘢痕后以健康黏膜覆盖，使其开放愈合，新发尿漏风险低。
2. 准备要点：遵守禁食禁药要求、提前治疗感染、做好短期带管准备、安排人员接送。
3. 术后数日内轻微烧灼感和淡红色尿液属正常现象；内镜复查确认疗效。若出现发热、无法排尿、新发大量尿漏或大量出血，请立即就医。